Déterminants de santé, prévention et promotion

UE C1 • CM3 « Déterminants et représentations » • S1 • IFSI 2026–2029

Objectif du cours

Comprendre comment les conditions de vie, l'environnement, les relations, les ressources et les services influencent la santé; repérer les leviers possibles et construire une action adaptée sans réduire la situation à un choix individuel.

1. Déterminants : de quoi parle-t-on ?

Un déterminant de santé est un facteur qui influence l'état de santé, favorablement ou défavorablement. Les facteurs agissent ensemble et peuvent se renforcer. La santé se construit au quotidien, là où les personnes naissent, grandissent, apprennent, travaillent, vivent et vieillissent.

Quatre grands champs du modèle de Lalonde

Champ	Exemples à explorer
Biologie et caractéristiques individuelles	Âge, sexe biologique, hérédité, état de santé, développement, capacités et parcours.
Environnement	Logement, qualité de l'air, bruit, sécurité, travail, école, transports, accès à l'eau et aux espaces verts.
Habitudes et modes de vie	Alimentation, sommeil, activité, consommation, liens sociaux; ces habitudes sont aussi influencées par les ressources et contraintes.
Organisation des soins	Disponibilité, coût, proximité, horaires, compréhension, continuité, accueil et coordination.

À retenir

Un comportement n'est pas expliqué par la seule volonté. Se demander « qu'est-ce qui rend ce choix possible ou difficile dans cette situation ? » ouvre une analyse plus juste.

2. Des conditions de vie aux inégalités de santé

Le modèle en arcs de Dahlgren et Whitehead représente plusieurs couches qui s’influencent, du plus proche de la personne aux conditions générales de la société.

Du centre vers l’extérieur	Exemples et questions de recueil
Caractéristiques individuelles	Âge, sexe, constitution et facteurs héréditaires; que faut-il prendre en compte pour cette personne ?
Modes de vie individuels	Alimentation, mouvement, sommeil, consommations; quels choix sont réalistes avec son quotidien ?
Réseaux sociaux et communautaires	Famille, proches, voisinage, associations, entraide; qui peut soutenir la personne si elle le souhaite ?
Conditions de vie et de travail	Revenus, emploi, logement, éducation, transport, accès aux soins et services; quels obstacles concrets sont présents ?
Contexte général	Politiques, économie, normes sociales, environnement et répartition des ressources; quels facteurs dépassent l’individu ?

Gradient social et équité

Dans une société, la santé tend à suivre un gradient social : quand les ressources et la position sociale diminuent, les possibilités d’être en bonne santé diminuent souvent aussi. Les différences ne sont pas toutes évitables; les inégalités de santé désignent notamment des écarts injustes et évitables.

Suivre le chemin entre cause et effet

Exemple : un logement humide peut aggraver une gêne respiratoire; un emploi précaire peut rendre les rendez-vous difficiles; une faible disponibilité alimentaire peut compliquer un régime adapté. Ces éléments ne posent pas un diagnostic. Ils orientent des questions, une surveillance, une action avec la personne et, si besoin, une orientation vers les ressources appropriées.

Posture

Décrire les conditions et leurs effets sans juger ni attribuer la responsabilité à la personne. Distinguer ce qui relève du soin, ce qui peut être travaillé avec elle et ce qui requiert une action collective.

3. Représentations et conduites de santé

Une représentation de santé est une manière de comprendre une maladie, un soin ou un risque, façonnée par l'expérience, les échanges, les informations disponibles et le milieu social. Elle peut guider les attentes, les inquiétudes et les décisions.

Explorer sans imposer

- Commencer par une question ouverte : « Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? », « Comment comprenez-vous ce traitement ? »
- Accueillir la réponse sans ridiculiser ni confirmer une information erronée; clarifier ce que la personne sait, croit, redoute ou souhaite.
- Vérifier la compréhension dans ses propres mots; adapter le vocabulaire, le rythme, les supports et la langue selon les besoins.
- Repérer les contraintes concrètes : horaires, transport, coût, alimentation disponible, fatigue, littératie, isolement ou accessibilité.
- Construire une proposition avec la personne; demander son accord avant d'impliquer un proche ou un partenaire, dans le cadre légal et institutionnel.

Croyances, pratiques et soins

Les croyances et pratiques peuvent soutenir la santé, être neutres ou parfois entrer en tension avec une recommandation. Ne pas généraliser à partir d'une origine, d'une religion ou d'un groupe. Explorer le sens attribué par cette personne et rechercher une solution sûre, compatible avec ses préférences et les exigences du soin.

IDE : observer et tracer avec précision

Noter les faits, les paroles utiles, les préférences exprimées, les obstacles identifiés, l'information donnée, la décision de la personne et la suite convenue. Éviter les étiquettes comme « non observant » sans décrire les raisons et le contexte.

Exemple de reformulation

« Vous me dites que le traitement est difficile à prendre quand vous travaillez de nuit. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Souhaitez-vous qu'on en parle avec l'infirmière référente ou le prescripteur ? »

4. Promotion, prévention et éducation

Promotion de la santé

La promotion vise à permettre aux personnes et aux communautés d'agir davantage sur leur santé et ses déterminants. Elle dépasse l'information individuelle : elle concerne aussi les environnements, les politiques, les ressources et la participation.

Charte d'Ottawa : 5 domaines d'action	Application possible en santé
Politiques publiques favorables	Prendre en compte la santé dans les décisions des différents secteurs.
Environnements favorables	Rendre les milieux de vie et de travail plus sûrs et favorables à la santé.
Action communautaire	Soutenir la participation des communautés à leurs priorités et décisions.
Aptitudes individuelles	Développer des connaissances et capacités utiles à des décisions éclairées.
Services réorientés vers la prévention	Associer prévention et promotion aux soins curatifs et à la continuité.

Trois niveaux de prévention

Niveau	Moment et objectif	Exemple
Primaire	Avant la maladie : réduire le risque d'apparition.	Vaccination, prévention du tabagisme.
Secondaire	Dépister ou repérer tôt pour intervenir au bon moment.	Dépistage selon les recommandations et l'éligibilité.
Tertiaire	Après le diagnostic : limiter complications, incapacités ou rechutes.	Suivi du diabète, réadaptation.

Éducation en santé

Définir un besoin avec la personne, choisir un objectif réaliste, proposer une information accessible et vérifier la compréhension. Une séance informative n'est pas à elle seule une preuve d'apprentissage ou de changement.

5. Mise en pratique et rôle infirmier

Une démarche simple en 6 étapes

Étape	Question à se poser
1. Écouter	Quel est le problème de santé et comment la personne le vit-elle ?
2. Contextualiser	Quelles conditions de vie, ressources, habitudes, relations ou contraintes ont un effet ?
3. Repérer	Quel risque, besoin ou levier est prioritaire aujourd'hui ?
4. Co-construire	Quel objectif est important et réalisable pour la personne ?
5. Agir / orienter	Quelle action relève du rôle IDE, de l'équipe ou d'un partenaire ?
6. Réévaluer	La solution est-elle comprise, faisable, utile et acceptable ? Que faut-il ajuster ?

Situation d'application

Une personne vivant avec un diabète explique qu'elle saute parfois des repas et a du mal à suivre les conseils alimentaires. Éviter de conclure à un manque de motivation. Explorer le budget alimentaire, les horaires, l'accès aux commerces, les préférences, la compréhension des conseils et les symptômes. Avec son accord, convenir d'une priorité réaliste, transmettre les informations utiles à l'équipe et solliciter les ressources adaptées selon l'organisation locale. Réévaluer ce qui a changé.

À connaître par cœur

Les déterminants interagissent. Les habitudes ne sont pas uniquement des choix individuels. Lalonde distingue biologie, environnement, modes de vie et organisation des soins. Dahlgren et Whitehead représentent des couches du proche au structurel. La Charte d'Ottawa décrit 5 domaines d'action. Prévention primaire = éviter l'apparition; secondaire = détecter tôt; tertiaire = limiter les complications.

Source du cours : Moodle IFSI, UE C1 CM3 « Déterminants et représentations », support de 80 diapositives (30/09/2026); fiche A5 déjà classée dans Drive. Repères complémentaires : OMS, Déterminants sociaux de la santé; Promotion de la santé, 03/11/2026; Charte d'Ottawa.